

Dispercepire il Mondo — Schema

Salute Mentale · Sessione 05

Semiologia — Concetti base

- **Segni** → indicatori oggettivi rilevabili dal curante
 - **Sintomi** → indicatori soggettivi riferiti dal paziente
 - **2 aree**: semiologia del comportamento · semiologia dello stato mentale attuale
-

Semiologia del Comportamento

- **Apparenza**
 - **Ipertimia** → mimica espressiva (**fasi maniacali**)
 - **Amimia** → mimica assente (**depressione, Parkinson**)
 - **Mimica discordante** → espressione ≠ emozione vissuta (**schizofrenia**)
- **Discorso** → velocità, tono, fluenza, bisogno di stimolazione
- **Condotte istintuali**
 - Cura del sé: igiene, alimentazione, sonno, relazioni
 - Disturbi del sonno: **risvegli precoci (umore)** · **insonnia iniziale (ansia)**
 - Disturbi sessuali e alimentari: temi delicati, spesso legati a effetti collaterali
 - Disturbi sfinterici: **nelle demenze (incontinenza urinaria → fecale)**
- **Passaggi all'atto**
 - Auto-aggressivi · etero-aggressivi
 - **Fuga dissociativa** → allontanamento post-trauma, amnesia episodio (**≠ allontanamento nelle demenze**)
 - Disturbi impulsivi: **piromania · cleptomania**
- **Funzioni psicomotorie**
 - Agitazione psicomotoria
 - **Catatonìa** → perdita iniziativa motoria + ipertono muscolare

- **Tic** → movimenti rapidi involontari al volto
- **Paracinesi** → movimenti alterati fuori contesto
- **Stereotipie** → sequenze comportamentali ripetute

Semiologia dello Stato Mentale Attuale

Coscienza

- **Cosciente** = sa chi è + sa dove è + reagisce all'ambiente
- Asse vigilanza · asse lucidità · asse coscienza di sé
- Alterazioni **quantitative**: lucidità → ottundimento → torpore → sopore → coma
- Alterazioni **qualitative**:
 - Stato confusionale/delirium
 - **Mania à potu** → mania da bassi quantitativi di alcol (**≠ delirium tremens = astinenza**)
 - Stato crepuscolare → epilessia, psicosi
 - Stato oniroide → tipo sogno, possibili allucinazioni visive
 - Automatismo → gesti abituali fuori contesto
 - Stupore → legato alla catatonia
 - Fenomeni dissociativi

Orientamento (3 domini)

Dominio	Labilità	Rilevanza clinica
Tempo	Alta (anche senza patologia)	Bassa se isolato
Spazio	Media	Significativa
Persona (so chi sono)	Bassa	Massima gravità

Spazio + tempo alterati → sospetto problematica cerebrale

Memoria

Tipo	Durata	Note
Sensoriale	1-2 sec	Iconica (visiva) · Ecoica (uditiva)
Breve termine	~20-30 sec	5-9 elementi · capacità limitata
Di lavoro	Variabile	Rielabora le info → funzioni esecutive
Lungo termine	Illimitata	Implicita + Esplicita

- **MLT implicita** → automatismi (guidare, lavarsi i denti)
- **MLT esplicita episodica** → eventi della vita
- **MLT esplicita semantica** → nozioni apprese

Disturbi quantitativi: - **Ipomnesia** → traccia ridotta - **Amnesia anterograda** → no codifica nuove info dopo evento indice - **Amnesia retrograda** → no recupero info prima dell'evento indice - **Ipermnesia** → capacità aumentata

Disturbi qualitativi (paramnesie): - **Falsi ricordi** → rievocazione involontariamente distorta - **Confabulazioni** → falsificazioni involontarie in stato lucido (es. **Korsakoff**) - **Déjà vu/vécu** → sensazione di familiarità, **non necessariamente patologica**

Attenzione

- **Selettiva** → focus su un obiettivo, esclude il resto
- **Divisa** → più fonti contemporaneamente (solo con schemi cognitivi diversi)
- **Sostenuta** → attenzione a lungo su compiti monotoni; **sensibile all'invecchiamento**

Percezione

- **Sensazione** → dato grezzo dai sensi
- **Percezione** → rielaborazione soggettiva del cervello basata sull'esperienza

Distorsioni quantitative: - Iperestesia → amplificazione - Ipoestesia → riduzione

Distorsioni qualitative: - Micropsia / Macropsia / Dismegalopsia - Dissociazione delle percezioni

False percezioni: - **Illusione** → stimolo reale + interpretazione erronea (affettiva, da completamento) — **non patologica di per sé** - **Allucinazione** → nessuno stimolo reale · percezione vissuta come reale

Agnosie → sensi integri, ma incapacità di riconoscere: - Visiva / Uditiva / Tattile / Gustativa - **Prosopagnosia** → incapacità di riconoscere volti - **Anosognosia** → incapacità di riconoscere il proprio stato di malattia

Funzioni Cognitive

- **Memoria** · **Attenzione** · **Funzioni esecutive** (problem solving, pianificazione, inibizione)
 - **Linguaggio** · **Prassie** (movimenti pianificati) · **Funzioni gnosico-percettive** · **Emozioni**
 - **Neurotrasmettitori principali:** dopamina · serotonina · noradrenalina · GABA · glutammato · acetilcolina
-

Psicofarmacologia

- **Emivita** → tempo per ridurre del 50% il farmaco nel sangue → **determina intervalli di somministrazione**
- **Farmacodinamica** → meccanismo d'azione
- **Farmacocinetica** → assorbimento, distribuzione, eliminazione

Classi principali

Classe	Bersaglio	Note chiave
Antipsicotici	Sintomi positivi (deliri, allucinazioni)	Tipici (1952) = più effetti coll. · Atipici (anni '90) = meno
Antidepressivi		

Classe	Bersaglio	Note chiave
	Depressione + ansia + OCD + altro	Bifasici: effetto dopo 2-3 sett. · rischio suicidale nelle prime sett.
Ansiolitici	Ansia acuta	Benzodiazepine: effetto immediato, dipendenza a lungo termine
Stabilizzatori	Disturbo bipolare	Litio: tossico se sovradosato · monitoraggio ematico necessario

⚠ Non dedurre la diagnosi dalla terapia farmacologica ⚠ La terapia è sempre integrata — il farmaco è una parte, non la soluzione

Autori / Date / Riferimenti

Chi	Cosa	Quando
Pewzner E.	Schema semiologia, disturbi attività operativa	2002
Sims A.	Alterazioni della coscienza, livelli	2009
Baddeley et al.	Memoria a breve termine, memoria di lavoro	2011
Valler & Papagno	Memoria, attenzione, agnosie	2011
Feldmann et al.	Sensazione e percezione	2017
Faravelli C.	Psicofarmaci: classi, effetti, definizioni	2010
Stahl S.M.	Antipsicotici, stabilizzatori dell'umore	2016
Rossi & Stratta	Funzioni cognitive e neuroscienze	2006

Parole chiave

semiologia · segni · sintomi · ipertimia · amimia · catatonìa · stereotipie · fuga dissociativa · coscienza · orientamento · mania-a-potu · amnesia-anterograda · amnesia-retrograda · confabulazione · déjà-vu · attenzione-selettiva · attenzione-

divisa · attenzione-sostenuta · sensazione · percezione ·
iperestesia · ipoestesia · illusione · allucinazione · agnosia ·
prosopagnosia · anosognosia · emivita · farmacocinetica ·
farmacodinamica · antipsicotici · antidepressivi · ansiolitici ·
stabilizzatori-umore · benzodiazepine · litio